

PROCORT[®]

Programa de Recuperación Optimizada en Cirugía Ortognática
Clínica Universidad de los Andes · Servicio de Anestesiología

Se ha demostrado que los protocolos de recuperación optimizada disminuyen las complicaciones y la duración de la estadía hospitalaria en varios tipos de cirugías. El programa en Cirugía Ortognática consiste en varias fases de cuidado: educación del paciente, régimen de medicación multimodal perioperatorio específico, deambulación precoz e inicio de régimen oral precoz. Los pacientes son dados de alta en su primer día postoperatorio si cumplen los criterios definidos. Los componentes se establecieron mediante la revisión de la literatura y guías disponibles.

FASE 1 — PREOPERATORIO

Educación pre-admisión

- Folleto de enfermería de visita preoperatoria.
- Contenido: principios y beneficios del protocolo de recuperación óptima en cirugía ortognática; instrucciones de medicamentos preoperatorios y carga de carbohidratos; instrucciones de alta precoz y postoperatoria; manejo de expectativas; exámenes preoperatorios.

FASE 2 — PERIOPERATORIO

Carga de carbohidratos

- **Bebida 1** (la noche antes de la cirugía): hasta 500 mL de bebida deportiva con azúcar (Gatorade o similar), o jugo de manzana/naranja sin pulpa.
- **Bebida 2** (hasta 2 horas antes de la hora programada): hasta 500 mL de bebida deportiva con azúcar (Gatorade o similar), o jugo de manzana/naranja sin pulpa.

Medicamentos preoperatorios al ingreso (4 horas antes)

- Ketoprofeno 100 mg
- Paracetamol 1 g
- Akynzeo[®]
- Pregabalina 75–150 mg VO

FASE 2 — INTRAOPERATORIO

Hipotensión controlada

Rangos de PAM a manejar durante la cirugía: 50–65 mmHg o un 30% por debajo del nivel basal del paciente. No bajar nunca de 50 mmHg en pacientes jóvenes ASA I, ni de 80 mmHg en adultos mayores (riesgo de hipoperfusión).
Contraindicaciones de la técnica: cardiopatía coronaria, hipertensión arterial no controlada y diabetes mellitus mal compensada.

Preparación y medidas

- Monitoreo habitual + PAI (toma de muestra).
- Trombopprofilaxis: medias + compresión neumática intermitente (CNI).
- Anestesia baja en opioides. Mantener normotermia, normoglicemia y normovolemia.
- Protección ocular con gel + sello. Oximetazolina 0,05% intranasal.
- Intubación nasal con tubo preformado. Pack doble retrofaríngeo.
- Ventilación mecánica con PEEP 5–10. Profilaxis antibiótica según protocolo.

Inducción

- Lidocaína 1,5 mg/kg EV.
- Propofol TCI diana 3–3,5. Remifentanil TCI diana 6–7.
- Precedex (dexmedetomidina) 0,5 µg/kg/hr.
- Esmeron (rocuronio) 0,5 mg/kg EV.
- Ketamina 0,15–0,25 mg/kg EV en bolo. Sulfato de magnesio 30–40 mg/kg EV.

Antiinflamatorios / analgésicos antes del inicio de la cirugía

- Dexametasona 8 mg EV. Parecoxib 40 mg. Paracetamol 1 g EV.
- Ketamina 0,15–0,25 mg/kg EV en bolo. Metadona 0,05–0,1 mg/kg al inicio.
- Ondansetrón 4 mg EV. Ácido tranexámico 25 mg/kg al inicio.
- Infiltración local por el cirujano con anestésico de acción prolongada.

Al despertar

- Semisentado.
- Neostigmina 0,07 mg/kg o Sugammadex (opcional), según TOF.
- Ondansetrón 4 mg EV al término de la cirugía.

FASE 2 — POSTOPERATORIO INMEDIATO

Máscara Venturi 6 L/min · Orthocooler.

- Régimen 0 por 30 min y luego régimen hídrico 30 mL c/15 min según tolerancia (cuchara o jeringa).
- Semisentado, cabeza a 45°. Levantar con ayuda 60 min tras llegar a la habitación y cada 4 h.
- Cefazolina 1 g EV c/8 h. Ondansetrón 4 mg EV c/8 h. Droperidol 1 mg EV SOS náuseas/vómitos. Metoclopramida 10 mg EV c/8 h (opcional).
- Betametasona 4 mg EV c/8 h. Ketoprofeno 100 mg c/8 h. Paracetamol 1 g EV c/8 h. Parecoxib 40 mg EV SOS.
- Omeprazol 40 mg EV/día. Zopiclona 7,5 mg noche.
- Enjuagues colutorios con clorhexidina c/8 h. Oximetazolina 1 spray por fosa nasal c/8 h. Lubricación labial con bálsamo horaria. Nebulizaciones SOS con suero fisiológico.
- Medias antiembólicas + compresión neumática intermitente hasta deambular.

FASE 3 — PRIMER DÍA POSTOPERATORIO

Requisitos para el alta (1° día PO)

- Sin evidencia de sangrado activo/excesivo.
- Reflejos de las vías respiratorias intactos.
- Capacidad de tragar líquidos sin problemas y tolerar dieta oral.
- Deambulación independiente. Micción de volúmenes apropiados sin dificultad.
- Adecuado control de dolor y náuseas. Indicaciones postoperatorias habituales al alta.

Analgesia al alta: Ketorolaco sublingual 30 mg c/8 h + Paracetamol 1 g c/8 h.

FASE 4 — SEGUIMIENTO Y SOPORTE

Control telefónico de la cirugía para reconocer eventuales complicaciones, según protocolos de la Clínica Universidad de los Andes. Evaluar la duración de la hospitalización, la tasa de reingreso a los 7 días, la tasa de complicaciones, el consumo de opioides, los episodios de náuseas y vómitos postoperatorios y la escala visual análoga de dolor a las 6, 12 y 24 h postoperatorias.

Referencia de apoyo del Servicio de Anestesiología — Clínica Universidad de los Andes. La decisión final es del anestesiólogo a cargo.